

건강보험심사평가원 상임감사

기관경고·개선요구

제 목 소위원회 운영관리 미흡

관 계 부 서 급여등재실

내 용

1. 업무개요

요양기관, 치료재료 수입·제조업자 등¹⁾은 의료행위가 이미 고시된 항목인지 신의료기술평가 신청대상인지 여부를 확인하고자 할 경우 건강보험심사평가원장에게 요양급여대상·비급여대상 여부(이하 “기존급여 여부”라 한다) 확인을 신청할 수 있다.²⁾

그리고 접수된 신청 건은 전문평가위원회³⁾의 검토를 거쳐 기존급여 여부를 확인하도록 되어있고⁴⁾, 전문평가위원회는 「전문평가위원회 운영규정」(이하 “위원회규정”이라 한다)에 따라 ■ 소위원회(이하 “■소위원회”라 한다)를 구성·운영하여 검토를 수행하고 있다.

이에 급여등재실은 ㉠소위원회에 대한 실무검토, 안건준비, 회의 소집·운영 등에 관한 사항을 전문평가위원회 위원장으로부터 위임받아 업무를 수행하고 있다.⁵⁾

1) 요양기관, 「의료법」 또는 「약사법」에 따른 의료인 단체, 의료기관 단체, 대한약사회 또는 대한한약사회, 치료재료의 제조업자·수입업자

2) 「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 제9조의2에 따라 신청가능하며 복지부장관에게 제출한 것으로 같음

3) 「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 제11조제8항에 따라 행위·치료재료에 대한 평가를 효율적으로 수행하기 위하여 건강보험심사평가원에 행위 및 치료재료별로 전문평가위원회를 둠

4) 「요양급여대상·비급여대상 여부 확인의 절차와 방법 등에 관한 기준」 제3조에 따라 확인하도록 되어있음

5) 위원회규정 제6조 및 제7조

2. 소위원회 위원구성 미흡

가. 관계규정(판단기준)

위원회규정 제5조의2제4항에 따르면 ㉠소위원회 위원은 3명 이상 10명 이내로 구성하되, 위원장 1명 및 학회가 추천하는 임상전문가 1명 이상, 건강보험·신의료기술평가 또는 인공지능·디지털기술에 대한 전문지식 및 경험이 있는 전문가 1명 이상을 포함하도록 되어있다.

그리고 같은 규정·조 제10항에 따르면 전문평가위원회 위원 중 회의안전 관련 분야의 전문가가 없는 경우 관련학회에서 추천받은 외부전문가를 회의에 출석시켜 의견을 들을 수 있도록 되어있다.

따라서 급여등재실은 ㉠소위원회 구성 시 관련 분야의 위원을 위원장 포함 최소 3명 이상 구성하고, 위원 중 관련 분야의 전문가가 없어 전문 의견을 제시할 수 있는 외부전문가를 구성한 경우에는 외부전문가가 의결에 참여하지 않도록 하여 공정하고 정확한 심의·의결이 이루어질 수 있도록 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

급여등재실은 ‘20. 2월~’23. 3월까지 총 136회의 ㉠소위원회를 개최하였고, 이 중 ‘21. 1월~7월까지 5회와 ‘22. 10월 1회의 총 6회(이하 “이 위원회”라 한다.)에 대한 참석자를 구성하면서, 안전관련 전문평가위원회 위원이 코로나19 대유행, 거리두기 단계 강화 등으로 참석불가⁶⁾ 및 전문가부재의 사유로 관련학회에 이 위원회에 참석 가능한 외부전문가를 요청 및 추천받아, 각 위원회 참석인원을 전문평가위원회 위원 2명, 외부전문가 1~3명으로 구성하여 총 25건의 안전을 의결하였다.

([별표 1]“㉠소위원회 위원 구성 내역” 참고)

6) 코로나19 3차 대유행(‘20.11.~’21.1.) 당시 월별 확진자 역대 최대 발생(‘20.12. 27,117명, ‘20.11. 8,017명) 및 거리두기 4~5단계 실시(‘20.11.7.~’21.10.31.)

그런데 이 위원회 위원을 2명으로 구성한 것은 위원회규정 제5조의2제4항에 따른 의결에 참여하는 위원의 최소 구성인원수 3명에 미달하게 된다.

또한 같이 참석한 1~3명의 외부전문가의 경우 이 위원회 계획·결과보고서에 같은 규정·조 제10항⁷⁾을 근거로 하여 관련 안건의 전문가로서 의견을 듣기 위해 참석시켰기 때문에 의결에 참여하는 위원으로서 구성되었다고 볼 수 없다.

3. 소위원회 의결정족수⁸⁾ 미준수

가. 관계규정(판단기준)

위원회규정 제5조의2제6항에 따르면 ㉠소위원회 의결은 선정위원 과반수 출석과 출석위원 과반수 찬성으로 하도록 되어있다.

따라서 급여등재실은 ㉠소위원회에 상정된 안건 의결 시 참석위원 수에 따른 의결정족수를 철저히 확인하여 상정된 안건이 공정하게 결정될 수 있도록 운영하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

제34차 ㉠소위원회(외과계, '22. 11. 25.개최)에는 선정위원 5명 모두(위원장 1명 포함) 출석하였고 상정된 안건 중 “㉡”에 대하여 신의료기술평가 신청대상으로 의결하였다.

이 안건이 의결되기 위한 의결정족수는 3명이상(참석위원 5명 중 과반수)으로 신의료기술평가 신청대상으로 결정되기 위해서는 3~5명의 위원이 이에 찬성하여야 한다.

그런데 이 안건의 회의 결과는 [별표 2]“제34차 ● 소위원회 안건별 검토확인서”와 같이 신의료기술평가 신청대상 2명, 기존기술 1명, 기권 2명으로 의결정족수가

7) 전문평가위원회 위원 중 회의 안건 관련 분야의 전문가가 없는 경우 관련학회에서 추천받은 외부전문가를 회의에 출석시켜 의견을 들을 수 있다.

8) 의결이 성립하는데 필요한 구성원의 최소 찬성표 수

충족되지 않아 의결이 성립하였다고 볼 수 없으므로 재논의가 필요한 안전임에도
기권을 제외한 위원의 과반수(3명 중 2명) 찬성이라는 이유로 신의료기술평가
신청대상으로 의결 및 통보하였다.

이로 인해 위원회규정의 의결정족수 기준을 준수하지 못 하였다.

4. 위원회규정 개선 필요

위원회규정(이하 모든 조항·별표는 위원회규정으로 한정한다) 제5조의2제4항에
따르면 ■소위원회의 위원 구성 시 “1.학회가 추천하는 임상전문가(이하 “임상전문가”라
한다)”와 “2.건강보험·신의료기술평가 또는 인공지능·디지털기술에 대한 전문
지식 및 경험이 있는 전문가(이하 “지식·경험전문가”라 한다)”를 위원으로 추출·
구성하도록 되어있다.

「전문평가위원회운영규정」 일부 발췌

제5조의2(요양급여대상·비급여대상 여부 확인 소위원회의 구성·운영 등)

- ④ 급여·비급여확인 소위원회는 위원장 1명 및 다음 각 호의 전문가를 포함하여 3명 이상 10명
이내의 위원으로 구성할 수 있다. 이 경우, 별표 3에 따른 각 군의 세부분야별로 추출하되,
안전에 따라 추출 시 세부분야 및 관련 전문가를 선택할 수 있다.

1. 학회가 추천하는 임상전문가: 1인 이상

2. 건강보험·신의료기술평가 또는 인공지능·디지털기술에 대한 전문지식 및 경험이 있는 전문가:
1인 이상

- ⑩ 급여·비급여확인 소위원회 위원장은 전문평가위원회 위원 중 회의 안전 관련 분야의 전문가가
없는 경우 관련학회에서 추천받은 외부전문가를 회의에 출석시켜 의견을 들을 수 있다.

제5조의3(치료재료 허가범위 초과 사용 평가 소위원회의 구성·운영 등)

- ④ 치료재료 허가범위 초과 사용 평가 소위원회 위원장은 제3항에 따른 위원 위촉 시 전문평가위원
회의 위원 중 우선 선정하며, 필요한 경우 진료심사평가위원회 심사위원, 관련학회의 추천을 받은
외부 전문가를 출석시켜 의견을 들을 수 있다

[별표 3]

2. 건강보험·신의료기술평가 또는 인공지능·디지털기술에 대한 전문지식 및 경험이 있는 전문가

※ 결정·조정기준 제12조제1항제6호에 따른 전문가 중 건강보험·신의료기술평가에 대한 전문지식
및 경험이 있는 전문가. 다만, 한방의 경우 별표1의 3군에 따른다.

한편 지식·경험전문가는 별표 3(제5조의2제4항 관련)에서 ‘결정·조정기준
제12조제1항제6호에 따른 전문가(전문평가위원회 위원) 중’에서 위원을 선정하도록
되어있고, 제5조의2제10항에 “전문평가위원회 위원 중 회의 안전 관련 분야의

전문가가 없는 경우 외부전문가를 회의에 출석시켜 의견을 들을 수 있다.”라고 되어있으며, 다른 소위원회인 “㉠ 소위원회”는 제5조의3에 따라 “위원 위촉 시 전문평가위원회의 위원 중 우선 선정” 하도록 되어있다.

따라서 전문평가위원회 소위원회의 위원 구성은 전문평가위원회 위원 중에서 우선 선정토록 한정되어 있는 것으로 판단되며, 이에 따라 제5조의2제4항에 따른 임상전문가는 전문평가위원회 위원 중에서 선정해야하는 것으로 판단된다.

그러나 같은 조항에 임상전문가에 대한 모집단⁹⁾이 명확히 표현되어있지 않아 임상전문가를 전문평가위원회 위원 중 구성하지 않고 관련학회로부터 추천을 받아 위원으로 구성하는 것으로 해석 및 적용될 가능성이 있다.

그리고 앞으로 새로운 감염병 또는 의료환경 변화 등으로 인하여 다양한 분야에 대한 기존급여 여부 확인 신청이 발생할 수 있으며, 이에 따라 전문평가위원회 위원 중에서 해당 분야 전문가를 위원으로 선정하는 것에 어려움이 발생할 가능성이 있다.

이로 인해 ㉠소위원회가 규정을 준수하지 못하거나 전문성이 부족하게 되어 공정하고 객관적으로 심의·의결되지 못할 우려가 있다.

9) 위원 추출·구성을 위한 대상 전체(전문평가위원회 위원POOL, 관련학회POOL 등)

관계부서 의견

① 소위원회 위원 구성 미흡 관련

기존급여 여부 확인 신청은 첨단기술 분야의 신기술 적용 등으로 복잡하고 다양해지고 있어, 안전에 따라 전문평가위원회 위원으로만 소위원회 위원을 구성하기 어려운 경우가 다수 발생되고 있으며, 당시 전문평가위원회 위원으로 모두 구성하고자 하였으나, 해당 기간은 코로나19가 전국적으로 확산되어 위중증·사망환자가 증가¹⁰⁾하여 범정부적 총력 대응한 시기로, 전문위원의 참석이 불가(진료일정, 전문분야 불일치, 코로나19 방역)하여 불가피하게 관련학회 추천을 받아 구성하였고, 더욱이 코로나19 검사 및 의료 인공지능¹¹⁾ 등의 분야는 전문평가위원회 위원 중 해당 세부 분야의 전문가가 부재한 것으로 확인되어 관련 안전을 검토하기 위한 위원 구성이 매우 어려웠다는 의견을 제시하였다.

② 소위원회 의결정족수 미준수 관련

의결정족수 기준을 준수하지 못한 것에 대한 감사결과를 수용하며, 해당 건은 신청업체에서 상기 기존기술여부 확인 신청 건에 대한 결정 취소를 요청('23. 6. 2.)하여 '23년 제18차 소위원회('23. 6. 9.)에 기존 소위원회 결정의 취소를 보고하고, 그 결과를 신청업체 및 신의료기술평가위원회에 통보하였다는('23. 6. 19.) 의견을 제시하였다.

③ 위원회규정 개선 필요 관련

위원회규정 제5조2제4항제1호의 임상전문가에 대하여 세부분야의 학회에서 추천된 전문가를 선택하여 소위원회 위원을 선정할 수 있다고 해석하여 운영

10) 코로나19 3차 대유행('20.11.~'21.1.) 당시 월별 확진자 역대 최다 발생('20.12. 27,117명, '20.11. 8,017명) 및 거리두기 4~5(최고)단계 실시('20.11.7.~'21.10.31.)

11) AI(인공지능)·디지털기술의 건강보험 적용 등 검토를 위한 ♥행위전문평가위원회는 2022년 11월에 구성되어 그 이전에는 전문가 부재하였음

하였으나, 감사결과에서처럼 소위원회 위원 구성에 대하여 잘 못 해석될 가능성이 있음을 인지하였으며, 기존급여 여부 신청이 첨단기술 분야 등 점차 복잡하고 다양해지고 있어 전문평가위원회 위원으로만 소위원회 위원을 구성하기 어려운 경우가 다수 발생되고 있어, 소위원회 구성 및 운영 현실에 부합되고 규정이 명확하게 해석되도록 전문평가위원회 규정의 개선을 추진하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 개발상임이사는

- ① 앞으로 「전문평가위원회운영규정」에 따른 ■ 소위원회 위원 구성 및 의결정족수를 철저히 준수하시고,
- ② 관련부서에는 향후 동일한 사안이 발생하지 않도록 경고를 촉구하시기 바라며,(기관경고)
- ③ ■ 소위원회 위원 구성에 대한 해석의 오해가 발생하지 않고, 앞으로 소위원회가 의료환경 변화 등에 전문적이고 유연하게 대응할 수 있도록 「전문평가위원회 운영규정」을 명확하고 합리적으로 개정하시기 바랍니다.(개선)

[별표 1]

■ 소위원회 위원 구성 내역

연번	회의일자	계획·결과 보고문서	문서제목	위원 참여 방법	전문평가위원회 위원 ¹⁾	외부 전문가 ²⁾	의결 인수
1	2021.1.22.	■부-83 (2021.1.21.) ■부-137 (2021.1.28.)	제2차 ■ 소위원회(검체검사 대면·영상회의) 3)검 토결과 보고	대면	이○○(위원장) 송○○	홍○○ 차○○ 김○○	5
2	2021.2.25.	■부-273 (2021.2.23.) ■부-336 (2021.3.8.)	제6차 ■ 소위원회(내과계 대면회의) 검 토결과 보고	대면	이○○(위원장) 손○○	김○○ 홍○○	2
3	2021.5.7.	■부-729 (2021.5.3.) ■부-795 (2021.5.13.)	제16차 ■ 소위원회(검체검사 대면회의) 검 토결과 보고	대면	이○○(위원장) 김○○	성○○	4
4	2021.6.28.	■부-1051 (2021.6.24.) ■부-1108 (2021.7.6.)	제24차 ■ 소위원회(검체검사 대면·영상회의) 검 토결과 보고	대면	이○○(위원장) 김○○	홍○○ 성○○ 차○○	6
5	2021.7.26.	■부-1200 (2021.7.21.) ■부-1287 (2021.8.3.)	제27차 ■ 소위원회(외과계 대면·영상회의) 검 토결과 보고	대면	박○○(위원장) 김○○	백○○	4
6	2022.10.24.	■부-1793 (2022.10.20.) ■부-1867 (2022.11.2.)	제30차 ■ 소위원회(가계 대면·영상 회의) 검 토결과 보고	대면	고○○(위원장) 차○○	허○○	4

- 주: 1. 전문평가위원회위원: 학회가 추천하는 임상전문가, 건강보험·신의료기술평가 또는 인공지능·디지털
기술에 대한 전문지식 및 경험이 있는 전문가
2. 외부전문가: 「전문평가위원회 운영규정」 제5조의2제10항에 따른 외부전문가
3. 대면-영상회의: 원주본원(운영진 일부), 서울 국제전자센터 영상회의실(위원·외부전문가) 간 회의

[별표 2]

제34차 □ 소위원회 안건별 검토확인서

제 34 차		소위원회 안건별 검토확인서			
1. 확인신청					
연 번	항목	급여· 비급여대 상항목과 동일(유사)	안·유고시 항목과 동일(유사)	신의료기술 평가 신청대상	기타의견
1	(확인신청) [Redacted]			✓	2:1:2 (1/2) 신의료기술 평가대상
2	(확인신청) [Redacted]	✓			
3	(확인신청) [Redacted]			✓	신의료기술 평가대상으로 가려졌음 신의료기술 평가대상
4	(확인신청) [Redacted]			✓	신의료기술 평가대상 평가대상 평가대상
5	(확인신청) [Redacted]	✓			
2. 기타안전					
연 번	항목	급여· 비급여대 상항목과 동일(유사)	안·유고시 항목과 동일(유사)	신의료기술 평가 신청대상	기타의견
1	(절의명) [Redacted]	✓			신의료기술 평가대상 신의료기술 평가대상 신의료기술 평가대상

※ 요양급여대상·비급여대상 여부 확인신청 관련 공개사항인 '신청행위 및 비교행위의 목적, 대상, 방법'에 대해서도 검토하였음을 확인합니다.

위원장: [Redacted] 서명: [Redacted]